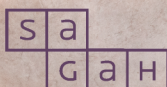


GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Gésica Graziela Julião



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Centro de resultados em saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você será capaz de:

- Identificar os centros de resultados em serviços de saúde.
- Relacionar cada centro de resultado com o processo organizacional.
- Descrever a participação de cada setor nos resultados da organização.

Introdução

Segundo a teoria clássica da administração, as cinco funções típicas de qualquer administrador devem ser: prever e planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. O setor da saúde vem reproduzindo essa tendência na administração gerencial, principalmente focando nos indicadores de gestão, em índices de desempenho e mensuração de qualidade com o objetivo de compreender a complexidade desses serviços.

O desempenho é um conjunto de características de comportamento ou rendimento de um indivíduo, de uma instituição, de um grupo ou processos em comparação às metas previamente definidas. Assim, está relacionado à ideia de superação de expectativas e pode ser entendido como produtividade e quantidade de trabalho. Para utilizar o índice de desempenho no processo gerencial, a instituição precisa ser avaliada por meio de um sistema eficaz de retroalimentação de acordo com suas estratégias e métodos de trabalho.

Da mesma forma, a construção de um clima satisfatório que atenda as necessidades dos trabalhadores permite que a instituição alcance um alto desempenho com ótimos resultados em saúde, uma vez que a estabilidade, o consenso e a motivação, além do ambiente de trabalho, são valores fundamentais. Portanto, um serviço de saúde é eficiente na medida em que se mantém por meio do equilíbrio entre os processos e os resultados, considerando os valores sociais, as normas e os objetivos da instituição.

Neste capítulo, você vai entender como as instituições de saúde utilizam os centros de resultados em seus processos gerenciais, bem como a interferência desses centros nos processos organizacionais e, ainda, a participação de cada setor nos resultados da organização.

Serviços de saúde e centros de resultados

A gestão financeira de uma organização pode ser dividida por setores ou centros de resultado com o objetivo de facilitar a identificação de onde os recursos financeiros são gastos e produzidos. Muitas organizações dividem as áreas em geradoras de receitas ou de despesas exclusivamente. Porém, existem segmentos que são responsáveis pela geração de ambas e, por isso, podem ser identificadas como geradoras de resultados. Os resultados da instituição são a base do processo de planejamento estratégico e, para tal, é preciso que haja um consenso do que pode ser reconhecido como tal (BARBOSA; BRONDANI, 2005; PAULO, 2016).

Na literatura, é possível encontrar muitas definições para resultado. Segundo Paulo (2016), a Organização das Nações Unidas (ONU) entende resultado como uma alteração, capaz de ser medida e descrita a partir de uma relação de causa e efeito, intencional ou não, positiva ou negativa. Pode-se considerar três tipos de resultados: o resultado da combinação dos vários fatores de produção o resultado ou efeito de uma ação, situação ou evento e os impactos gerados a longo prazo (PAULO, 2016).

O relatório de centro de resultados, por sua vez, é utilizado para reconhecer um resultado final dentro de um panorama maior. Assim, quanto maior é o seu detalhamento, melhor é a qualidade das informações obtidas dele. Dessa forma, é possível aprimorar algumas tomadas de decisões na empresa, como definir limites de crédito por setor para evitar gastos desnecessários e identificar setores que merecem mais investimentos por gerar mais lucros. Para facilitar esse controle e registrar corretamente todas as informações, é fundamental que a instituição possua um *software* de gestão para automatizar o processo e fornecer resultados precisos para uma avaliação mais ágil (SPILLER, 2009).

Na gestão de serviços de saúde, é importante que os resultados sejam compartilhados com todos aqueles que participam de sua geração, aqueles que serão afetados pelas ações desencadeadas da tomada de decisão após a sua avaliação e com aqueles que colocarão em prática as ações definidas. Sendo dessa maneira,

é fundamental ter aceitabilidade dos atores envolvidos a fim de que os resultados sejam legitimados e utilizados da melhor forma pelos gestores e técnicos (CAR-NUT; NARVAI, 2016).

Existem muitas formas de abordar o tema gestão por resultados, tais como gestão de desempenho, gestão por objetivos, controle de gestão, entre outros. Logo, o plano estratégico deve ser capaz de comunicar quais são os resultados buscados pela organização e como eles podem ser medidos, monitorados e transformados em responsabilidade coletiva. Os resultados são responsáveis por moldar a estrutura de uma instituição e seus mecanismos de incentivo (PAULO, 2016).

O centro de resultado deve ser administrado pela instituição de acordo com a estrutura organizacional — não se trata de simplesmente utilizar o organograma da instituição e transformar os setores em centros de resultado, mas isso pode acontecer. O centro divide a empresa em áreas com vistas a um melhor gerenciamento contábil e a uma maior facilidade no conhecimento dos gastos, fornecendo o custo de produção do período, uma vez que um centro de resultados é avaliado pela margem produzida. Ou seja, é decisão do gestor definir os meios que afetam tanto os processos de entrada quanto os processos de saída, nos quais ambos conseguem ser medidos monetariamente.

Os centros de resultado podem corresponder a um ou mais setores delimitados no organograma da organização ou podem ser um projeto. Portanto, é nesse ponto que os centros de resultado trabalham, analisando o que cada segmento ou projeto produz dentro dos objetivos da instituição. Segundo Spiller (2009), o mapeamento dos centros de resultados é uma ferramenta de gestão que, se bem utilizada, oferece ao gestor informações importantes sobre os erros na gestão dos recursos financeiros da instituição e, com isso, favorece a tomada de decisões de modificações se necessário.

A divisão por setores na área da saúde é bem comum e necessária, seja no âmbito público ou no privado. Em uma instituição hospitalar, por exemplo, os setores são facilmente identificados, uma vez que cada setor visa concentrar as atividades correspondentes (GONÇALVES *et al.*, 2010). Dessa forma, considerando as particularidades de cada instituição, a organização em centros de resultados busca corresponder aos interesses estratégicos da gestão. Para essa organização, comumente, o gestor procura identificar e medir o consumo de recursos humanos, materiais, etc. utilizado pelos setores, o que facilita à gerência da instituição definir como esses resultados serão tratados.



Exemplo

Veja, a seguir, os centros de resultados de uma instituição hospitalar de acordo com as atividades desenvolvidas pelos diferentes setores.

- Centro de resultados de ambulatório: envolve os serviços ambulatoriais prestados por equipe multiprofissional e a assistência médica especializada.
- Centro de resultados de assistência domiciliar: envolve todos os serviços de assistência à saúde realizados dentro do domicílio do paciente.
- Centro cirúrgico: diz respeito aos serviços de assistência pré-operatória, anestesia, intraoperatório e recuperação pós-anestésica do paciente.
- Centro obstétrico: engloba todas as atividades cirúrgicas de obstetrícia, entre elas, parto vaginal, parto cesáreo, curetagem, etc.
- Unidades de internação: todas as unidades de internação clínicas, cirúrgicas, obstétricas, pediátricas, ortopédicas, psiquiátricas, entre outras.
- Centros de resultados de assistência médica: envolve os centros de custos das unidades de terapia intensiva (UTI) adulta, pediátrica e neonatal.

Alguns autores classificam os centros de resultado em dois tipos: aqueles que estão diretamente ligados à produção dos serviços finais da instituição e aqueles que oferecem suporte a essa produção. A partir dessa, podem ocorrer subdivisões de acordo com as necessidades de cada instituição (BRASIL, 2013). Considerando que em uma instituição de saúde o serviço ou produto final é a assistência multiprofissional e o paciente atendido, é interessante classificar os centros de resultados por grupo de prestação de serviço ou de atividades realizadas. Assim, a prestação de serviços ao paciente é responsável pela entrega do produto final da instituição. Já os centros de resultados de suporte são aqueles que trabalham para os centros de resultados produtivos. Por exemplo, o serviço de nutrição e dietética de um hospital, o departamento de compras, a lavanderia, a farmácia, o laboratório, o centro de materiais esterilizados, a segurança, a telefonia e a coleta de resíduos são setores que não trabalham diretamente na assistência do paciente, mas são essenciais para a consolidação do trabalho dos profissionais de saúde, assim como os setores administrativos, que são absolutamente necessários para a manutenção da instituição. Portanto, uma medida que facilita a gestão das instituições de saúde é considerar que cada setor é uma unidade de negócio ou uma empresa independente que presta serviços entre si, simulando uma cadeia interna de cliente-fornecedor (GONÇALVES *et al.*, 2010).

Centros de resultado e processo organizacional

Ainda que a área de atuação da saúde seja muito específica, o hospital consiste em uma empresa como outra qualquer, o que significa que precisa definir estratégias e processos de gestão financeira, eficientes para aumentar a produtividade, diminuir os desperdícios e aperfeiçoar a operação. Seu objetivo é oferecer um atendimento de excelência aos usuários, um ambiente com condições adequadas para a produção de cuidado e um bom funcionamento da instituição.

O trabalho em saúde é essencialmente coletivo, compartimentado, interdependente e marcado pela incerteza da demanda. Além disso, os serviços de saúde não são passíveis de padronização, pois, ainda que os protocolos sejam utilizados, não é possível replicar de forma idêntica as ações; eles dependem de recursos humanos muito qualificados, com escolaridade mínima de segundo grau completo e formação na área específica de saúde e apresentam fragmentação organizacional, ou seja, um mesmo paciente pode depender de várias instituições diferentes porque nem todos os serviços de saúde possuem os recursos necessários para resolver os problemas de um usuário (CARNUT; NARVAI, 2016).

Ao considerar as especificidades da área da saúde enquanto serviço, Carnut e Narvai (2016) destacam a evidente complexidade da gestão quando se trata de sistemas de saúde, que são compostos por organizações que têm como meta problemas sociais ou de saúde, serviços preventivos, paliativos, diagnósticos e curativos, além das ações da saúde pública, ainda que não possuam responsabilidades diretas sobre o conjunto das condições sociais, econômicas e culturais que determinam as condições de saúde das pessoas.

De acordo com Carnut e Narvai (2016), a medida de desempenho que é importante para a avaliação dos resultados é difícil de ser mensurada pelos sistemas de saúde, pois não existe uma constância ao longo do tempo. O conflito se encontra no fato de não ser possível medir todas as áreas, o que resulta em gerenciamento daquilo que é medido e negligência ou dúvida sobre aquilo que não o é. Assim, avaliar o desempenho de sistemas de saúde demanda um modelo conceitual, no qual os bancos de dados disponibilizem informações necessárias à construção dos indicadores e à avaliação e tomada de decisão pela gestão (TANAKA; TOMAKI 2012).

É de conhecimento geral que a informação é um recurso importante dentro de uma organização, assim como a incorporação de novas tecnologias de informação também é um recurso valioso para o desenvolvimento de uma boa gestão. A informação mobiliza recursos capazes de otimizar o desempenho organizacional, mas, para que isso aconteça, ela precisa ser bem utilizada e o

gestor precisa dominar os mecanismos de gestão para o uso desse recurso. Ao mesmo tempo, a baixa disponibilidade de informações básicas e de qualidade resulta em fatores limitantes para criar indicadores de gestão, fundamentais para embasar as ações e as políticas públicas do sistema de saúde brasileiro (GARCES; SILVEIRA, 2002).

Cabe salientar que a produção de informação depende de processos bem organizados, o que significa que o almoxarifado, a farmácia, o serviço de nutrição e dietética, a lavanderia, entre outros, devem estar organizados para proporcionar informação precisa e sem viés. Da mesma forma, é necessário que a instituição possua uma base de Tecnologia da Informação integrada, passível de comunicação inter e intrasetorial, como um indicador de resultado a fim de priorizar a eficácia e a qualidade dos serviços. Portanto, para implantar a gestão de resultados em uma instituição, as ações devem estar sistematizadas e articuladas nos diferentes níveis gerenciais e operacionais.

Um sistema de gestão de resultados é fundamentado por dados, informação e conhecimento. A informação constitui ação estratégica importante dentro da instituição quando bem analisada. Por isso, é papel do gestor identificar como os dados estão sendo gerados, por que eles podem ser transformados em indicadores de saúde e quais decisões podem ser tomadas a partir deles, de modo a melhorar os resultados e minimizar danos à instituição. O alinhamento entre os objetivos estratégicos e a metodologia aplicada na produção da informação garante que os resultados gerados atendam à legislação vigente e às exigências gerenciais (SPILLER, 2009).

Esse rigor metodológico na obtenção dos dados exige uma organização dos processos internos de trabalho. Então, pode-se entender que todos os processos envolvidos na incorporação de um sistema de gestão de resultados — a produção dos dados, a organização para esta produção e a análise dos dados — são ótimos ganhos para a instituição de saúde. Com isso, considera-se a riqueza da utilização de uma gestão por centro de resultados, e não apenas uma gestão por centro de custos.

Participação de cada setor nos resultados da organização

Com a grande revolução tecnológica e empresarial que ocorreu no século XX, a gestão de custos e resultados migrou de ferramenta exclusiva para a mensuração e o controle de custos e lucros para uma ferramenta fundamental

à tomada de decisões gerenciais, considerando a competitividade do mercado (BRASIL, 2013). Portanto, o avanço na utilização dessa ferramenta gerencial permitiu a criação de diferentes sistemas e métodos capazes de mudar o cenário da gestão em saúde tanto no sistema privado quanto no público.

O setor privado é o pioneiro em implantação de tecnologias gerenciais direcionadas para a gestão de custos e resultados, e essas tecnologias, por sua vez, são adquiridas pelo setor público. Essa questão merece atenção, uma vez que se essas tecnologias forem incorporadas de forma imprópria, sem adequar-se às realidades da função pública, podem ocasionar em efeito indesejado quanto à leitura e aplicação de seus resultados (GARCES; SILVEIRA, 2002; BRASIL, 2013). Assim, para a utilização da abordagem de custos do setor privado pelo setor público, é necessária a adequação de conceitos para que a transposição seja a mais adequada possível para o setor público.

O desenvolvimento da gestão de custos e resultados no Sistema Único de Saúde (SUS) tornou-se necessária a partir da obrigação de garantir maior eficiência na aplicação dos recursos e sustentabilidade do sistema. Por isso, o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) foi criado com o objetivo de otimizar o desempenho de serviços, unidades, regiões e redes de atenção em saúde do SUS (BRASIL, 2013). Em 1964, a Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964) foi instituída a fim de definir as normas gerais de controle orçamentário da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ou seja, as fontes e os investimentos dos recursos financeiros no SUS. A lei está em vigor até os dias atuais, mas não possui caráter de obrigatoriedade em sua implantação.

Alguns anos depois, em 2000, foi instituída a Lei Complementar nº. 101 (BRASIL, 2000), conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina diretrizes para o equilíbrio fiscal dos órgãos federados e preconiza, em seu art. 50 § 3º, que a administração pública deve manter um sistema de custos que possibilite uma avaliação e um acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Considera, portanto, o conhecimento dos custos e resultados dos serviços públicos como essencial para atingir uma disponibilização de recursos eficiente.

De modo igual, a gestão de resultados no SUS busca garantir a qualidade da atenção em saúde por meio de um consumo adequado de recursos, um padrão de referência em cuidados e informação eficaz sobre o funcionamento do financiamento do sistema. No setor privado, a gestão de resultados busca, além de lucros por meio de corte ou redução de recursos, produzir relatórios úteis para o planejamento e controle de operações, emitir relatórios que pro-

porcionem suporte à tomada de decisões e formulação de planos e políticas de ação e custear produtos para determinar os lucros (BERTÓ; BEULKE, 2005).

Os mesmos autores classificam a gestão de custos e resultados em três instâncias: a primeira é aquela dirigida aos interesses externos e condicionada às obrigações legais e fiscais; a segunda é voltada aos interesses internos e tem como objetivo produzir informações úteis para auxiliar na tomada de decisão; já a terceira está voltada para a análise de custos de estoque, controle, planejamento e ações gerenciais de acordo com os objetivos da organização.

Nesse contexto, percebe-se que a apuração de custos no setor público se fundamenta na utilização das informações acerca da informação, seu significado e sua representatividade, identificando “quais” e “como” os recursos são utilizados para a prestação de serviços ou produção de produto. Ou seja, o custo da prestação de um serviço público representa como foram consumidos recursos humanos, materiais e equipamentos para determinado fim.

Assim, decodificar a informação torna-se um instrumento essencial de gestão, fornecendo material para o planejamento e a elaboração de indicadores de serviço, de resultado e de processo, além de indicadores econômicos e de desempenho, com vistas a garantir a qualidade do serviço entregue à comunidade. Um sistema de custos e resultados ideal precisa ser capaz de combater o desperdício, facilitar a prestação de contas pela gestão, além de ser o controle social dos serviços públicos.

De acordo com Bertó e Beulke (2005), alguns conceitos em gestão de custos e resultados devem ser conhecidos, como os custos fixos e variáveis de uma instituição. Custos fixos são aqueles nos quais não ocorre alteração de valor mesmo quando o volume produzido é modificado ou não há produção, como seguro institucional, aluguel das instalações, etc. Já os custos variáveis são aqueles que alteram de acordo com as variações de produção, de mão de obra direta e de materiais.

Desse modo, dependendo do foco de atuação da instituição, alguns setores possuem maiores custos variáveis do que outros. Por exemplo, é bem provável que em um hospital de referência em cardiologia os setores com maior custos variáveis sejam o centro cirúrgico, a UTI e a unidade de internação, em detrimento do pronto-atendimento, da pediatria e da maternidade. Portanto, a análise de resultados por setor é fundamental para manter a instituição dentro do planejamento esperado ou modificar algumas ações a fim de evitar prejuízos futuros à organização.

Para realizar a gestão de custos e resultados de uma unidade ou setor, é recomendável a definição das unidades de medida. Sabendo que alguns centros de resultados utilizam seus recursos em um produto principal e outros utilizam seus recursos com vários produtos, pode-se analisar a questão da seguinte forma: na lavanderia, o produto principal é o quilograma de roupa lavada; na central de material esterilizado (CME), o produto final é o pacote esterilizado. Dessa forma, é possível identificar uma unidade de produção que pode ser analisada e gerenciada de acordo com os resultados alcançados (BRASIL, 2013).

A equipe gerencial precisa mapear esses processos para conseguir estimular o desempenho das melhores práticas de produção que alcance um resultado eficiente e eficaz. Para mapear essas atividades, é imprescindível que os trabalhadores de cada setor contribuam com as informações a respeito de sua rotina de trabalho, das etapas do processo desde o início até a geração do produto final.



Saiba mais

Para visualizar esses cenários de forma didática e acessível à compreensão de todos, é útil o uso de fluxogramas, que servem para representar esquematicamente um processo.

A partir daí, para cada atividade desenvolvida, são definidos os recursos humanos, materiais e de equipamentos que são necessários. No entanto, com relação aos serviços de assistência ao paciente, há uma ampla variação de tempo e de recursos necessários. Nesses casos, a gestão deve identificar a quantidade máxima e mínima de recursos utilizados, permitindo, assim, definir um intervalo no qual cada procedimento deve estar enquadrado.

Ter essas informações de forma clara é importante para realizar o gerenciamento de qualquer instituição, pois, por meio delas, é possível saber onde, quanto e como os recursos estão sendo utilizados e, assim, identificar precocemente a necessidade de adequar os processos. Essa base de conhecimento permite o planejamento e o controle gerencial desde o momento em que são definidas as atividades desempenhadas por cada setor da instituição e os recursos necessários para sua realização.



Referências

BARBOSA, E. R.; BRONDANI, G. Planejamento estratégico organizacional. *Revista Eletrônica de Contabilidade*, v. 1, n. 2, p. 107-123, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/view/107/3735>. Acesso em: 3 jan. 2020.

BERTÓ, D. J.; BEULKE, R. *Gestão de custos e resultado na saúde: hospitais, clínicas, laboratórios e congêneres*. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.

BRASIL. Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 5 maio 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 3 jan. 2020.

BRASIL. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. *Diário Oficial da União*, 23 mar. 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 3 jan. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. *Introdução à gestão de custos em saúde*. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. v. 2. *E-book*. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/introducao_gestao_custos_saude.pdf. Acesso em: 3 jan. 2020.

CARNUT, L.; NARVAI, P. C. Avaliação de desempenho de sistemas de saúde e gerenciamento na gestão pública brasileira. *Saúde e Sociedade*, v. 25, n. 2, 2016. Disponível em: https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0104-12902016000200290&script=sci_arttext. Acesso em: 3 jan. 2020.

GARCES, A.; SILVEIRA, J. P. Gestão pública orientada por resultados no Brasil. *Revista do Serviço Público*, v. 53, n. 4, p. 53-77, 2002.

GONÇALVES, M. A. *et al.* Gestão estratégica hospitalar: a aplicabilidade do sistema ABC em um bloco cirúrgico. *Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde*, v. 4, p. 73-86, 2010.

PAULO, L. F. A. Planejamento estratégico e gestão por resultados: o caso do Ministério da Saúde. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 26, n. 3, p. 981-1.007, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000300981&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 3 jan. 2020.

SPILLER, E. S. *et al.* Fundamentos da gestão dos serviços em saúde. *In*: SPILLER, E. S. *et al.* *Gestão dos serviços em saúde*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

TANAKA, O. Y.; TAMAKI, E. M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 4, p. 821-828, 2012. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232012000400002&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 3 jan. 2020.

Leitura recomendada

BEHN, R. D. O novo paradigma da gestão pública e a busca pela accountability democrática. *Revista do Serviço Público*, v. 49, n. 4, p. 5-43, 1998.



Fique atento

Os *links* para *sites* da Web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS